Carte 01

Que désigne un déterminant de santé ?

Carte 02

Comment distinguer facteur de risque et analyse des déterminants ?

Carte 03

Que rechercher avant d'attribuer une difficulté de traitement à un manque de volonté ?

Carte 04

Quels sont les quatre champs du rapport de Lalonde ?

Carte 05

Pourquoi le tabac ne se réduit-il pas à un risque de cancer ?

Carte 06

Pourquoi un repère de réduction des risques n'est-il pas un seuil d'absence de risque ?

Carte 02

Un facteur de risque est associé à une probabilité accrue de problème ; l'analyse des déterminants examine aussi les conditions de cette exposition.

Carte 01

Un facteur personnel, social, économique ou environnemental qui influence la santé d'une personne ou d'une population.

Carte 04

Biologie humaine, environnement, habitudes de vie et organisation des soins.

Carte 03

Le coût, la compréhension, les horaires, le logement et les ressources de soutien disponibles.

Carte 06

Limiter une exposition peut réduire certains risques sans les supprimer.

Carte 05

Le tabac contribue aussi à des maladies cardiovasculaires et à des atteintes respiratoires.

Carte 07

Quels types de conséquences de l'alcool faut-il garder en tête ?

Carte 08

Pourquoi ne peut-on pas additionner automatiquement les coefficients de risque du tabac et de l'alcool ?

Carte 09

Pourquoi une séance de sport ne décrit-elle pas à elle seule la sédentarité ?

Carte 10

Dans les repères Obépi 2020, faut-il additionner 47,3 % et 17 % ?

Carte 11

Peut-on transposer le gradient social du tabac à toutes les consommations ?

Carte 12

Que manque-t-il à un conseil alimentaire quand la personne ne peut pas cuisiner ?

Carte 08

Les expositions peuvent interagir ; une règle d’addition ne peut pas être supposée.

Carte 07

Des atteintes de plusieurs organes, des cancers, ainsi que des accidents et des chutes.

Carte 10

Les personnes en situation d’obésité sont incluses dans les 47,3 pour cent en excès de poids.

Carte 09

La sédentarité concerne aussi le temps passé assis ou allongé hors sommeil dans des activités peu dépensières.

Carte 12

Une réponse à la contrainte matérielle et la recherche de solutions réellement accessibles.

Carte 11

Non. Le sens et l’ampleur du gradient dépendent de l’exposition et de l’indicateur étudiés.

Carte 13

Que trouve-t-on au centre du modèle de Dahlgren et Whitehead ?

Carte 14

À quelle couche appartiennent la famille, le voisinage et les réseaux d'entraide ?

Carte 15

Pourquoi les cinq couches ne sont-elles pas cinq causes indépendantes ?

Carte 16

Pourquoi « modifiable » ne signifie-t-il pas « facile à changer » ?

Carte 17

Que représente le capital social dans l'analyse de la santé ?

Carte 18

Par quels mécanismes les conditions de travail peuvent-elles influencer la santé ?

Carte 14

Aux réseaux sociaux et communautaires.

Carte 13

L’âge, le sexe biologique, la constitution et l’hérédité.

Carte 16

Une habitude peut être modifiée tout en restant contrainte par le budget, le travail, le logement ou l’entourage.

Carte 15

Les niveaux sont imbriqués et s’influencent : les conditions collectives façonnent les ressources et les habitudes.

Carte 18

Par les expositions, la pénibilité, les horaires, le stress, la fatigue et les ressources matérielles.

Carte 17

Les ressources relationnelles accessibles à travers les proches, les groupes et les réseaux d’entraide.

Carte 19

Pourquoi une urgence de logement peut-elle passer avant une démarche de soins ?

Carte 20

Que recouvre le niveau des déterminants structuraux ?

Carte 21

Que sont les déterminants commerciaux de santé ?

Carte 22

Que cherche à faire le lobbying ?

Carte 23

Pourquoi un indicateur alimentaire ne résout-il pas toutes les contraintes de choix ?

Carte 24

Quel est le risque d'attribuer toute la santé aux choix individuels ?

Carte 20

Les politiques, les règles collectives et le contexte économique qui répartissent les ressources et les conditions de vie.

Carte 19

Des besoins matériels immédiats peuvent rendre la démarche difficile à organiser ou moins prioritaire pour la personne.

Carte 22

Influencer des décisions et des règles dans l'intérêt d'acteurs ou de secteurs.

Carte 21

Les effets directs ou indirects sur la santé d'activités poursuivant un objectif commercial.

Carte 24

Oublier les effets de l'offre, des prix, de la publicité et des conditions de vie.

Carte 23

Un indicateur alimentaire aide à comparer mais ne décrit pas tout l'aliment et ne supprime ni le coût ni les contraintes matérielles.

Carte 25

Que désignent les inégalités sociales de santé ?

Carte 26

Pourquoi le gradient social dépasse-t-il l'opposition entre pauvres et riches ?

Carte 27

Comment lire un écart de 40,5 à 48,5 années d'espérance de vie à 35 ans ?

Carte 28

Une association entre PIB et espérance de vie prouve-t-elle une hausse automatiquement proportionnelle ?

Carte 29

Quelle différence faire entre sexe biologique et rapports sociaux de genre ?

Carte 30

Quel problème révèle une plainte banalisée à cause d'un stéréotype ?

Carte 26

Des écarts peuvent apparaître tout au long des positions sociales.

Carte 25

Des écarts de santé entre groupes sociaux, liés à des mécanismes sociaux et institutionnels.

Carte 28

Le graphique décrit une association à l'échelle des pays, sans établir une règle de hausse automatiquement proportionnelle.

Carte 27

Il s'agit de huit années restantes d'écart en moyenne entre les groupes comparés, dans la période étudiée.

Carte 30

Un biais de reconnaissance du besoin et un risque de réponse inadaptée.

Carte 29

Le sexe renvoie aux caractéristiques biologiques ; le genre aux rôles, normes et rapports sociaux.

Carte 31

Comment la crainte d'être jugé peut-elle influencer le recours aux soins ?

Carte 32

Que signifie l'adéquation des soins ?

Carte 33

Quelles sont les trois étapes du parcours d'accès étudié ?

Carte 34

Quelle différence faire entre accès et recours ?

Carte 35

Quel obstacle rencontre une personne qui reconnaît un besoin mais manque de transport ?

Carte 36

Pourquoi une consultation ne garantit-elle pas la poursuite des soins ?

Carte 32

La correspondance entre les besoins réels et la réponse proposée, avec des compétences et une organisation adaptées.

Carte 31

Elle peut altérer la confiance et décourager ou retarder la démarche.

Carte 34

L’accès concerne les possibilités d’obtenir des services ; le recours est la démarche effective vers l’offre.

Carte 33

Percevoir le besoin, recourir aux soins, puis utiliser et poursuivre les soins.

Carte 36

Le coût, le temps, les contraintes quotidiennes et l’adaptation de la réponse peuvent encore faire obstacle.

Carte 35

Un obstacle matériel au recours aux soins.

Carte 37

Quelles sont les quatre opérations de la littératie en santé ?

Carte 38

Les deux approches de la littératie sont-elles concurrentes ?

Carte 39

Quels obstacles peut créer une prise de rendez-vous numérique ?

Carte 40

Comment rendre une démarche plus accessible pendant un échange ?

Carte 41

Comment définir le non-recours ?

Carte 42

Qu'est-ce que la non-connaissance ?

Carte 38

Non. Elles se complètent : compréhension des soins et possibilités d'agir pour la santé dans la vie quotidienne.

Carte 37

Accéder à l'information, la comprendre, l'évaluer et l'utiliser.

Carte 40

Employer des mots accessibles, expliciter les étapes et vérifier ce que la personne a compris.

Carte 39

Un manque d'équipement, une difficulté à utiliser l'outil ou à comprendre les étapes.

Carte 42

L'ignorance de l'existence d'une offre ou d'un droit.

Carte 41

La situation d'une personne qui ne bénéficie pas d'une offre, d'un droit ou d'un service auquel elle pourrait prétendre.

Carte 43

Qu’est-ce que la non-demande ?

Carte 44

Qu’est-ce que la non-réception ?

Carte 45

Quels sont les trois niveaux d’intervention de santé publique ?

Carte 46

Comment définir l’universalisme proportionné ?

Carte 47

Pourquoi une offre identique pour tous peut-elle laisser persister des inégalités ?

Carte 48

Comment appliquer l’universalisme proportionné à une information de santé ?

Carte 44

Une demande a été engagée mais la personne ne reçoit pas effectivement la prestation ou le service.

Carte 43

Une offre est connue mais aucune demande effective ou complète n’est faite.

Carte 46

Une action destinée à tous, avec une intensité adaptée aux besoins et aux obstacles.

Carte 45

Individuel et familial, communautaire, et systémique.

Carte 48

Proposer l’information à tous et ajouter un accompagnement selon les difficultés de langue, de mobilité ou de numérique.

Carte 47

Les personnes disposent de ressources différentes pour en bénéficier ; sans adaptation, les écarts peuvent persister ou s’accroître.

Carte 49

Que représente la roue des interventions de santé publique ?

Carte 50

Quelle différence faire entre surveillance et orientation ?

Carte 51

Que signifie l'aller-vers ?

Carte 52

Comment distinguer plaidoyer et marketing social ?

Carte 53

Pourquoi relier une stratégie publique à une action concrète ?

Carte 54

Pourquoi l'alimentation mobilise-t-elle plusieurs couches de déterminants ?

Carte 50

La surveillance suit des indicateurs ; l'orientation met en relation avec des ressources adaptées et veille à la suite.

Carte 49

Dix-sept fonctions réparties en cinq familles, articulées aux trois niveaux d'intervention.

Carte 52

Le plaidoyer cherche à influencer les décisions pour la santé ; le marketing social adapte une communication à un public et à cet objectif.

Carte 51

Les professionnels se rendent auprès des personnes ou des communautés, au lieu d'attendre leur venue.

Carte 54

L'alimentation dépend des pratiques, des réseaux, de l'offre accessible, des conditions économiques et des politiques.

Carte 53

Pour identifier les déterminants visés et les niveaux par lesquels l'intervention peut agir.

Carte 55

Pourquoi les spécificités d'un territoire ne sont-elles pas un caractère biologique inné ?

Carte 56

Que permet un projet alimentaire territorial ?

Carte 57

Comment élargir l'analyse d'un traitement difficile à suivre ?

Carte 58

Pourquoi commencer par décrire le besoin et la demande sans jugement ?

Carte 59

Comment vérifier qu'une aide devient réellement utile ?

Carte 60

Pourquoi ne faut-il pas déduire tout le comportement d'une catégorie sociale ?

Carte 56

Rapprocher des acteurs et des ressources alimentaires pour faciliter des évolutions adaptées à un territoire.

Carte 55

Les spécificités territoriales renvoient notamment à des contextes culturels, sociaux et environnementaux.

Carte 58

Pour comprendre la difficulté réelle avant d'en déduire une cause ou une intention.

Carte 57

Explorer les contraintes, la compréhension, les ressources et les possibilités d'accompagnement avec la personne.

Carte 60

Une tendance collective ne décrit pas toute la situation, les ressources ou les choix d'une personne.

Carte 59

Vérifier la compréhension, la possibilité de faire la démarche et la persistance éventuelle d'autres obstacles.